

表1 学会分類（日本結核病学会病型分類）

a. 病巣の性状	
0型：病変が全く認められないもの。	
I型（広汎空洞型）：空洞面積の合計が拡がり1（後記）を越し、肺病変の拡がりの合計が一側肺に達するもの。	
II型（非広汎空洞型）：空洞を伴う病変があつて、上記I型に該当しないもの。	
III型（不安定非空洞型）：空洞は認められないが、不安定な肺病変があるもの。	
IV型（安定非空洞型）：安定していると考えられる肺病変のみがあるもの。	
V型（治癒型）：治癒所見のみのもの。	
以上の他に次の3種の病変があるときは、特殊型として次の符号を用いて記載する。	
H（肺門リンパ節腫脹）	
P/（滲出性胸膜炎）	
Op（手術のあと）	
b. 病巣の拡がり	
1：第2肋骨前線上縁を通る水平線以上の肺野の面積をこえない範囲。	
2：1と3の中間。	
3：一側肺野面積をこえるもの。	
c. 病側	
r：右側のみに病変のあるもの。	
l：左側のみに病変のあるもの。	
b：両側に病変のあるもの。	
d. 判定に際しての約束	
i）判定にさいし、いずれに入れるか迷う場合には、次の原則によって割り切る。	
ⅠかⅡはⅡ、ⅡかⅢはⅢ、ⅢかⅣはⅣ、ⅣかⅤはⅤ	
ii）病側、拡がりの判定は、Ⅰ～Ⅳ型に分類しうる病変について行い、治癒所見は除外して判定する。	
iii）特殊型については、拡がりはなしとする。	
e. 記載の仕方	
i）（病側）（病型）（拡がり）の順に記載する。	
ii）特殊型は（病側）（病型）を前記の記載の次に付記する。特殊型のみのときは、その（病側）（病型）のみを記載すればよい。	
iii）V型のみのときは（病側）（拡がり）は記載しないでよい。	

[日本結核病学会用語委員会：新しい結核用語事典，<https://www.kekkaku.gr.jp/books/pdf/kanmatu.pdf> より許諾を得て転載]

γの産生量から感染を診断する方法である。クオンティフェロン®TBゴールドプラス（QFT-Plus）とT-スポット®、TB（T-SPOT）の2種類の検査法がある。BCG接種の影響を受けず、ツ反より診断精度が高い検査であり、メタアナリシスによれば、感度は70～90%、特異度は概ね90%以上と報告されている²⁾。

治療と予後

a 治療

i）感染症法の規定

結核は感染症法による「2類感染症」に分類され、医師は活動性結核の患者を診断した際は、ただちに最寄りの保健所に発生届を提出しなければならない（感染症法第12条）。保健所はこの発生届を受けて、患者、医療機関と連携しながら、患者の治療、感染の拡大を防ぐための対策といった結核患者管理を始めることになる。結核の医療費に関しては感染症法による公費負担制度がある（感染症法第37条、第37条の2）。

ii）抗菌化学療法

結核治療の中心は抗菌化学療法である。薬剤耐性菌の出現を防ぎつつ、結核患者の体内に生存する結核菌を速やかに撲滅することを目標に、患者に感染している結核菌に有効な（感受性がある）、作用点が異なる抗結核薬を初期には少なくとも3剤以上組み合わせた多剤併用療法を行う。活動性結核の初回標準治療を表

2に示す³⁾。

streptomycin（SM）は注射剤であるため、通常はethambutol（EB）が選択されるが、治療開始時にすでに視力障害がある場合はSMを選択する。肝不全、非代償性肝硬変、またはそれに準じた状態、慢性活動性C型肝炎、痛風、妊婦に対しては、pyrazinamide（PZA）の使用は避け、維持期を3ヵ月延長して7ヵ月（トータル9ヵ月）とする。また、治療開始2ヵ月を超えても培養陰性化が得られない症例、重症例（粟粒結核、広汎空洞型など）、再治療例、免疫抑制状態の症例（糖尿病、HIV感染、副腎皮質ステロイド薬・免疫抑制薬投与症例など）に対しては、再発率が高いので、維持期を3ヵ月間延長する。服用回数は、血中濃度の上昇および服薬確認とアドヒアランスの観点から、1日1回での服用が推奨される。

治療効果の判断および副作用の早期発見のため、月に少なくとも1回は喀痰抗酸菌検査、肝機能検査などを行う。特に治療初期2ヵ月間は使用薬剤も多く、副作用の発現も多い時期なので2週間に1回以上は血液生化学検査を行う。また、EB使用時は眼の検査、SM使用時は聴力、腎機能検査を行う。

診断時に検出された結核菌について薬剤感受性を確認しなくてはならない。もし薬剤耐性があれば感受性薬に変更して治療を行うことになる。特に、isoniazid（INH）とrifampicin（RFP）は重要な薬剤であ